СТОМЫ: базовые нормативы.

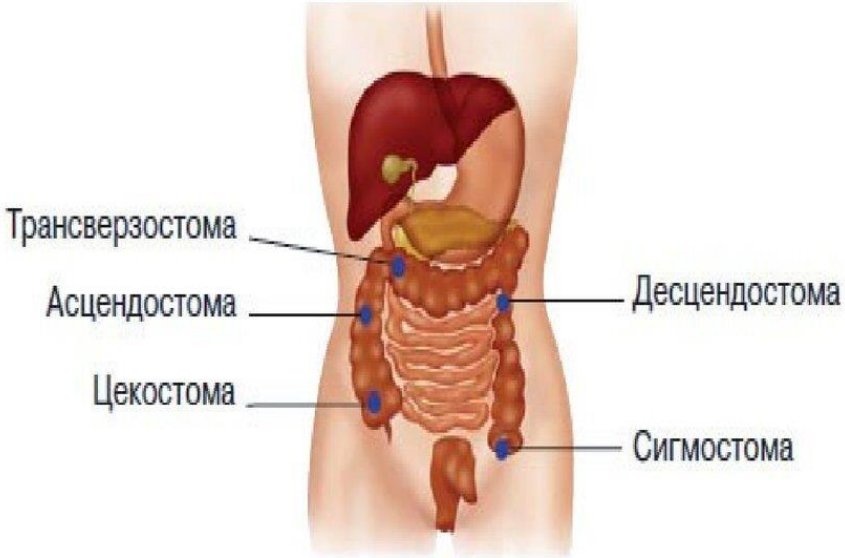
Главный внештатный колопроктолог МЗ РК
Астафьев Дмитрий Сергеевич

- Термин «стома» (ostomy.греч.)-обозначает отверстие кишки, сформированное хирургическим путём, после удаления всего или части кишечника, выведенное на переднюю брюшную стенку и предназначенное для отведения содержимого кишечника.
- Стома не имеет замыкательного аппарата и лишена болевых нервных окончаний.

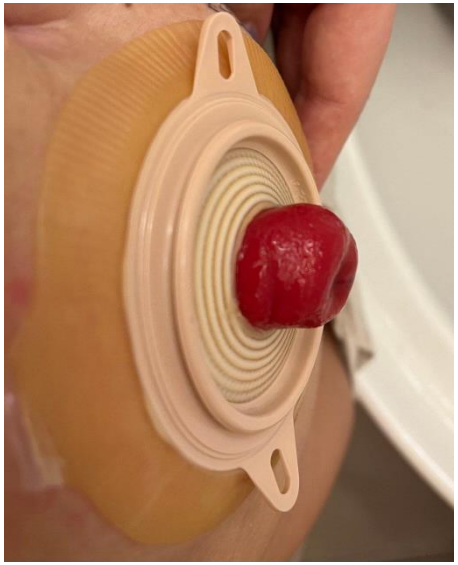
КЛАССИФИКАЦИЯ:

По месту формирования

- 1) Илеостома.
- 2) Колостома.



- ПО ФОРМЕ:
- 1)Выпуклая
- 2)Плоская
- 3)Втянутая



- **По количеству стволов:**
- **1) Одноствольная**
- **2)Двуствольная**

Одноствольная стома

Двуствольная петлевая стома

Двуствольная раздельная стома

- По прогнозу:
- 1) Постоянная
- 2) Временная

ОСЛОЖНЕНИЯ:

- 1. Дерматит (до 40 %)
- 2. Кровотечение (до 10%)
- 3. Стеноз (до 18%)
- 4. Втянутость (детракция — до 10%)
- 5. Выпадение (до 15-20%)
- 6. Грыжа (до 5%)
- 7. Гипергрануляции (до 4-5%)

ПОКАЗАНИЯ:

- 1. Онкология (острая кишечная непроходимость или невозможность радикального удаления опухоли)
- 2. Язвенный колит (осложненное течение)
- 3. Врожденная аномалия (атрезия)
- 4. Болезнь Крона (осложненное течение)
- 5.Дивертикулит (осложненное течение)
- 6.Кишечно-влагалищные и кишечно-мочепузырные свищи.
- 7. Аноректальное недержание кала
- 8. Ранение (повреждение) кишки

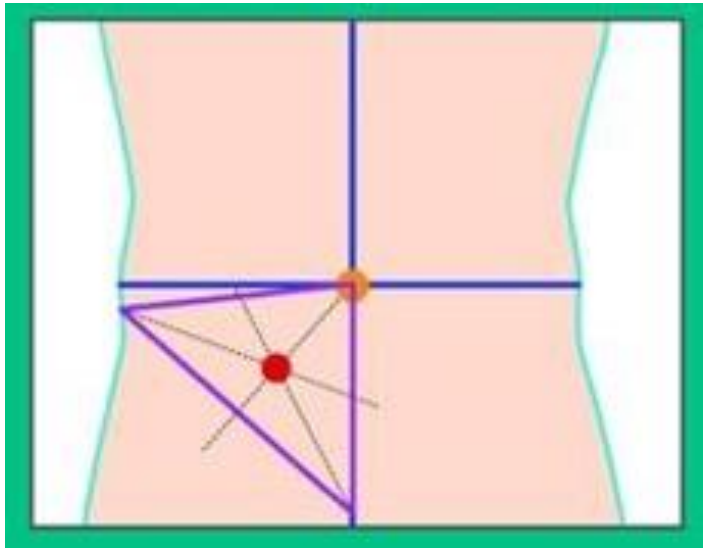
Основные проблемы

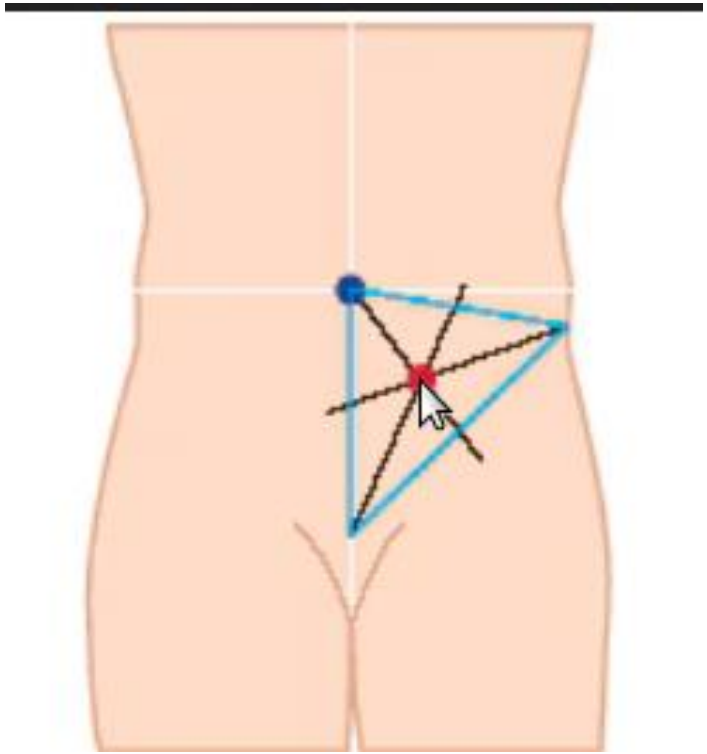
- 1. Стома наложена не в том месте
- 2. Нарушена техника наложения

Основные принципы

1. Стома не должна быть «выведена в бок»
2. Не должна укрываться под линию талии
3. Не должна находиться в кожной складке либо под ней
4. У пациента не должно быть препятствий для ухода за ней

Наиболее оптимальные точки выведения стом





Техника выполнения

1. Формирование стомального канала
2. Мобилизация кишки, достаточная для безнатяжного выведения
3. Подготовка площадки кишки для формирования полноценного и надежного кишечно-кожного шва (с захватом только серозно-мышечного слоя кишки)
4. Оценка кровотока выводимого участка.
5. Разбортировка кишечной стомы.

.Профилактика осложнений кишечных стом

1. Рациональный выбор места формирования стомы
2. Адекватный способ формирования кишечной стомы
3. Соблюдение техники формирования стомы
4. Организация ухода за стомой сразу после ее формирования
5. Правильное использование средств ухода за стомой
6. Динамический контроль стомированных больных

.Спасибо за внимание!!